TUT'ECOS

HÉMATOLOGIE
Complications transfusionnelles
Sans patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : William Bouregba **Date de rédaction : 30/01/2023**

Situation de départ N°272 – Prescrire et réaliser une transfusion sanguine

Domaine de compétence n°1 : Stratégie Pertinente de prise en charge

Domaine de compétence n°1 : Communication interprofessionnelle

Attendus d'apprentissage de la situation abordée :

1- Prendre en charge une complication et une réaction transfusionnelle immédiate

2- Contacter l'établissement français du sang et le correspondant d'hémovigilance en cas d'accident transfusionnel

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Etudiant simulant l'interne surveillant la transfusion et donnant les informations demandées

Matériel nécessaire à la station

1. Mannequin
2. Brancard
3. Téléphone
4. Test de Beth Vincent
5. CGR
6. Ordonnance de PSL
7. Poche de sondage urinaire (urines concentrées peu abondantes)

Instructions à l'étudiant

Vous êtes Urgentiste en MGU à l'hôpital Pasteur.

Vous recevez Monsieur Février, 68 ans, hospitalisé pour altération de l'état général. Le patient présente de lourds antécédents, à savoir une HTA, une dyslipidémie, un diabète et un syndrome coronarien aigu en 2012 avec insuffisance cardiaque ischémique séquellaire. Durant le séjour, il a été découvert une anémie avec une Hb 6,7 g/dl mal tolérée, pour laquelle une transfusion de CGR a été décidée.

30 minutes après le début de la transfusion, votre interne vous appelle car le patient est très dyspnéique et ne parvient plus à s'exprimer de façon compréhensible.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Demander les informations pertinentes (anamnèse, clinique) à l'interne et énoncer à haute voix la prise en charge dans l'immédiat
2. Énoncer à haute voix le diagnostic le plus probable dans le contexte
3. Prendre contact avec un correspondant, synthétiser le cas et déclarer l'événement indésirable

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tâche 1	
Arrête la transfusion	
Identifie la nécessité de maintenir la voie veineuse	
Recherche une erreur de patient ou de produit (vérification du lien patient – produit – document)	
Inspecte le produit (couleur, hémolyse) à la recherche d'un accident infectieux	
Récupère le contrôle ultime et les produits injectés en évitant toute contamination rétrograde	
Demande les paramètres vitaux : -température, pouls, tension, fréquence respiratoire, saturation -Auscultation cardio-pulmonaire, inspection générale -Volume de diurèse et couleur des urines	
Prescrit un traitement symptomatique adapté : -Oxygénothérapie au masque -Mise en position assise / demi-assise -Traitement diurétique IV (Furosémide) -Dérivés nitrés (sous réserve d'une PAS > 100_110 mmHg)	
Tâche 2	
Identifie qu'il s'agit d'un TACO (transfusion-associated circulatory overload) = OAP hémodynamique de surcharge	
Evoque le principal diagnostic différentiel , le TRALI (transfusion related acute lung injury) = OAP lésionnel	
Tâche 3	
Identifie la nécessité de réaliser un signalement sans délais au correspondant d'hémovigilance de l'établissement français du sang	
Appel le correspondant d'hémovigilance -Synthétise la situation (patient, antécédents, anamnèse) -Annonce son hypothèse diagnostique	
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à planifier les soins	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge	
Aptitude à faire la synthèse des données	

	Pondération
Tâche 1	
Arrête la transfusion	1
Identifie la nécessité de maintenir la voie veineuse	1
Recherche une erreur de patient ou de produit (vérification du lien patient – produit – document)	1
Inspecte le produit (couleur, hémolyse) à la recherche d'un accident infectieux	1
Récupère le contrôle ultime et les produits injectés en évitant toute contamination rétrograde	1
Demande les paramètres vitaux : - Température, pouls, TA, fréquence respiratoire, saturation - Auscultation cardio-pulmonaire - Volume de diurèse et couleur des urines	3
Prescrit un traitement symptomatique adapté : - Oxygénothérapie au masque - Mise en position assise / demi-assise - Traitement diurétique IV (Furosémide) - Dérivés nitrés (sous réserve d'une PAS > 100-110 mmHg)	2
Tâche 2	
Identifie qu'il s'agit d'un TACO (transfusion-associated circulatory overload) = OAP hémodynamique de surcharge	2
Évoque le principal diagnostic différentiel, le TRALI (transfusion related acute lung injury) = OAP lésionnel	1
Tâche 3	
Identifie la nécessité de réaliser un signalement sans délais au correspondant d'hémovigilance de l'établissement français du sang	1
Appel le correspondant d'hémovigilance - Synthétise la situation (patient, antécédents, anamnèse, accident transfusionnel) - Annonce son hypothèse diagnostique - Décrit les éléments de prise en charge	2
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à planifier les soins	1 à 4
Aptitude à proposer une prise en charge	
Aptitude à faire la synthèse des données	
Note totale	**/20**

Informations Complémentaires : Mr Février, 68 ans

- Antécédents :
- HTA
- Dyslipidémie
- Diabète
- SAOS
- Obésité (1,70 m, 87 kg, IMC 30,1 kg/m2)
- SCA en 2012 avec pose de stent sur l'IVA, avec insuffisance cardiaque ischémique séquellaire
- Traitements :
- Ramipril
- Bisoprolol
- Eplérénone
- Dapagliflozine
- Aspirine
- Statine
- Metformine
- PPC nocturne
- Allergies : 0
- Toxiques :
- Tabac 50 PA
- OH : 2 verres / jour
- Mode de vie :
- Ancien plombier retraité
- Vit avec sa femme

- Constantes :
- TA 175/97 mmHg
- FC 90 bpm
- Température 36,7 °C
- Saturation 89% en AA
- Fréquence respiratoire 32/min
- Patient sondé, faible diurèse avec des urines d'aspect concentrées non hématuriques

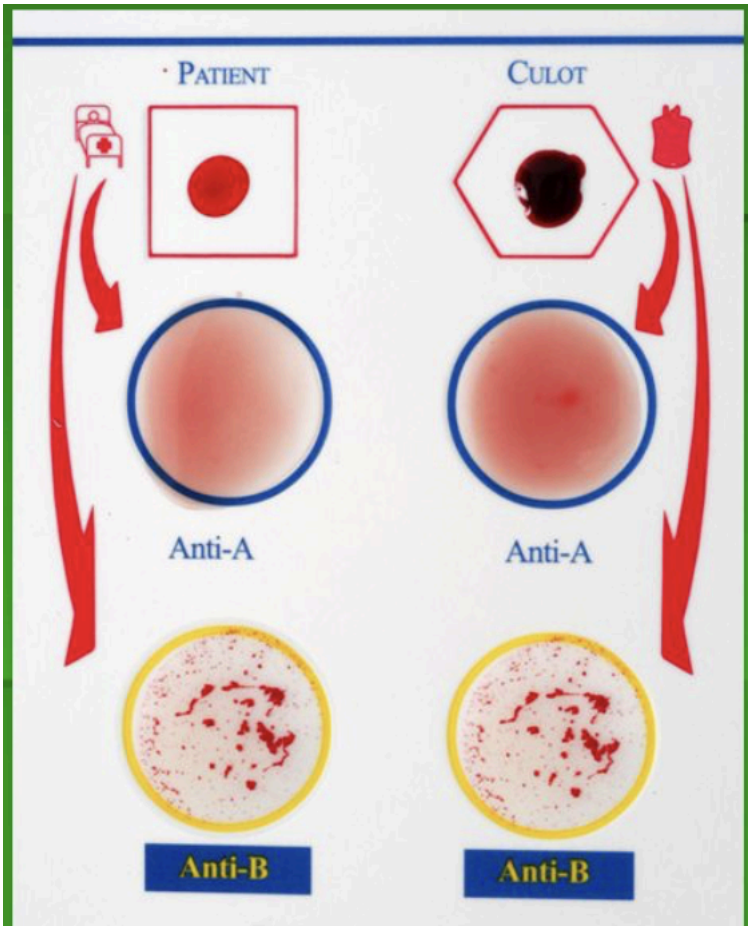
- Inspection

- Pas d'obstruction des VAS
- Dyspnée sévère, Polypnée superficielle
- Tirage sus claviculaire et intercostal
- Parle avec des mots (communication impossible), Cyanose digitale
- Pas de signes d'insuffisance circulatoire
- Pas de signes de déficience neurologique

- Examen cardio-pulmonaire:

- Bruits du coeur réguliers, pas de souffle
- Pas de douleur thoracique

- Crépitants bilatéraux remontant jusqu’à mi-champs
- Sibilants expiratoires
- Turgescence jugulaire
- Toux productive, avec expectorations mousseuseuses roses saumonées
- Signes de lutte x faillite respiratoire



Test de Beth Vincent compatible avec une transfusion

CGR d’aspect normal, non hémolysé, non purulent

Ordonnance de PSL, de bonne réalisation

ORDONNANCE DE PRODUITS SANGUINS LABILES

N° ordonnance : 05301120200408120357

Service prescripteur : **MEDECINE INTENSIVE REANIMATION**
Téléphone :

Nom de naissance :
Nom usuel :
Prénom :
Sexe :
IPP :
Date naissance :

Service transfuseur :
Téléphone :

Date de la prescription
Date / heure souhaitées de la transfusion :

Urgence relative

Pathologies à signaler lors de la première transfusion

☐ Drépanocytose ☐ Thalassémie ☐ Hémopathie ☐ Greffe CSH ☐ Greffe d'organe ☐ Hépatopathie Chronique ☐ SMD

CONCENTRÉ DE GLOBULES ROUGES (CGR)

Commande ferme

☐ Traceur température

Hb : (g/dL)
Indication clinique :

☐ Sans qualification, ☐ Phénotypés RH KEL1, ☐ Compatibilisés, ☐ Irradiés,
☐ Autres

CONCENTRÉ DE PLAQUETTES (CP)

Commande

Poids :

☐ Avec qualification, ☐ HLA compatibles, ☐ HPA compatibles ☐ Déplasmatisés,
☐ CPA ☐ MCP

Indication :

☐ Thrombopénie ☐ Thrombopathie

PLASMA FRAIS CONGELÉ (PFC)

Commande

Poids :
☐ VHE négatif

Indication : ☐ Hémorragie aigue, ☐ CIVD, ☐ Déficit fact. de coag, ☐ Echanges plasmatiques,
☐ Autres

Commentaires

PRESCRIPTEUR

Nom et prénom Téléphone/DECT :

RESERVÉ SITE DE DÉLIVRANCE

Modifications de la prescription

Date ..... **Nom de la personne jointe** .....

Visa